

37. DAS PRAKTISCHE GEHIRN

DAUER : 13:08

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video „Das Praktische Gehirn“ präsentiert einen detaillierten biodynamischen Ansatz, der sich auf das Gehirn und seine Expansion konzentriert. Der Dozent lehrt, wie man die Expansionsgrade beim Patienten identifiziert, indem er effektive Revitalisierungsstrategien wie die Arbeit am Herzen und an den Verdauungsachsen erforscht. Es folgt eine Untersuchung der zerebralen und pontinen Flexionsbewegungen mit spezifischen Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Berührung zu beachten sind. Durch die Konzentration auf das Gefühl der Expansion lernen die Praktiker, die Enzephalisationsbewegung zu begleiten und den Rhythmus und die Synchronizität zu verstehen, die mit der biodynamischen Embryologie verbunden sind. Diese Sitzung ist sowohl theoretisch als auch praktisch und verspricht den Studenten ein erweitertes Verständnis und entwickelte Fähigkeiten zur Verbesserung ihrer Praxis.

37. DAS PRAKTISCHE GEHIRN: EIN BIODYNAMISCHER ANSATZ

I. AUSGANGSPOSITION UND SUCHE NACH EXPANSION

Ich positioniere mich über dem Patienten, speziell auf Höhe der **Insel**. Meine Hände sind hier platziert, meine Daumen kreuzen sich leicht, und ich stelle sicher, dass meine Ellbogen und Handgelenke einen guten Auflagepunkt auf dem Tisch haben.

Die **Berührung** ist extrem sanft. Ich versuche, die **Expansion** des Feldes zu spüren.

A. DAS ERKENNEN MANGELNDER EXPANSION

Das Allererste, was zu beurteilen ist, ist das Ausmaß der **Expansion**. Wenn die Expansion unzureichend ist und ich nicht ausreichend "weggedrückt" werde, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.

Oft erwartet man eine sofortige und starke Expansion, aber das ist nicht immer der Fall.

B. REVITALISIERUNGSTRATEGIEN BEI MANGELNDER EXPANSION

Wenn die Expansion unzureichend ist, gibt es mehrere Wege, um das System zu **revitalisieren**:

- **Das Herz:** Das Entlasten des Herzens ist oft ein sehr effektiver Ansatz.

- **Die Verdauungsachsen:** Die Arbeit an den Verdauungsachsen (mesenterial, mesarrisch) oder der Zöliakusachse kann die notwendige Expansion bringen.
- **Das Sakrum und die Pedikel:** Das Aufsteigen zum Sakrum und zu den Pedikel-Ebenen kann ebenfalls helfen.

Im Allgemeinen führt die Arbeit mit dem Herzen oder den Verdauungsachsen zu schnelleren und effektiveren Ergebnissen.

II. DIE FLEXIONSBEWEGUNG UND DIE ENZEPHALISIERUNG

Sobald die Expansion vorhanden ist, spüre ich eine Expansion, gefolgt von einer **Flexionsbewegung** nach vorne. Dies ist die zervikale Flexion, die das Gehirn zum Herzen bringt.

Dahinter muss ich eine Bewegung der **zervikalen Flexion** wahrnehmen. Wenn ich hier ein leichtes Defizit spüre, deutet dies auf die Notwendigkeit einer zervikalen oder strukturellen Korrektur hin.

A. DIE PONTINE FLEXION UND DIE TELENCEPHALISATION

Ich konzentriere mich dann auf meine kleinen Finger und suche die **pontine Flexion**. Die Bewegung geht nach unten.

Dann erscheint eine neue Expansion. In diesem Stadium kann ich meine Hand öffnen. Dies ist der Beginn des Prozesses der **Telencephalisation**, der vom okzipitalen zum temporalen Niveau zurückgewonnen wird.

B. HÄUFIGE FEHLER UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Die meisten Fehler treten auf, wenn man das Gehirn direkt berührt. Es ist zwingend erforderlich, das Gehirn nicht zu berühren, wenn man nicht "auf dieser Frequenz" ist.

- Ich positioniere mich darüber, ohne mit den Daumen zu berühren, und halte einen schönen Abstand.
- Ich erzeuge einen sehr sanften **Fulcrum** mit meinen Daumen und einem wichtigen Auflagepunkt.

C. DAS GEFÜHL DER EXPANSION

Eine gute Expansion wird als Wärmeebene und ein Gefühl sanften Schiebens empfunden.

III. DIE SEQUENTIELLE BEWEGUNG UND DIE BEGLEITUNG

Ich führe eine sehr sanfte Bewegung aus. Das ist noch nicht mein "insulärer H-Brücke". Ich mache die Flexionsbewegung nach vorne. Die Bewegung geht gut nach unten, kann aber leicht in Torsion geraten (zum Beispiel nach links). Ich begleite diese Torsion sehr leicht.

In diesem Stadium kann eine kleine Korrektur notwendig sein, möglicherweise auf Herzhöhe. Es kann einen Moment geben, in dem die Bewegung nicht perfekt ist, aber das ist nicht schlimm.

A. ABSTIEG DER FLEXION UND PONTINE EBENE

Ich gehe dann zum Abstieg der Flexion über, den der Patient deutlich spüren muss. Das geht problemlos nach unten.

Sobald dies etabliert ist, gehe ich zur **pontinen Ebene** über. Auch hier kann ein kleiner Eingriff erforderlich sein.

B. DIE TELENZEPHALE EBENE UND DIE AUFSTEIGENDE EXPANSION

Nach der pontinen Ebene richte ich meine Aufmerksamkeit auf die **telenzepitale Ebene**, die telenzepitale Anlage. Die Bewegung muss auf mich zukommen. Ich beobachte eine Expansion.

Ich positioniere mich auf dem **"Hitchman"**: Die Bewegung dreht sich zu mir, expandiert und steigt auf.

C. DIE GROßE ENZEPHALISIERUNGSBEWEGUNG

Die Bewegung setzt sich fort, geht wieder nach unten und drückt sich aus. Ich gehe ganz sanft in die große Flexion, die große Bewegung der **Enzephalisierung** zurück. Ich hole diese Bewegung auf okzipitaler Ebene zurück.

Es ist entscheidend, diese Bewegung zu begleiten, sie nicht aufzuzwingen. Man wartet, bis sie sich zeigt, und folgt ihr dann. Die Bewegung ist bereits vorhanden, wie eine "gezeichnete Schiene", mit einem bestimmten Rhythmus. Man reproduziert nur das vorhandene **Muster**.

IV. DAS VERSTÄNDNIS DES RHYTHMUS UND DER SYNCHRONIZITÄT

Dieses Muster ist nicht reproduzierbar im Sinne eines periodisch wiederkehrenden Zyklus. Es ist ein System, das ständig da ist, eine **Schrift im Körper**. Das ist die Essenz der **biodynamischen Embryologie**: Die Anlage der Strukturen (Ohren, Augensystem, Augenplakode usw.) entsteht nach diesem Muster.

Wir werden dieser Erkenntnis weitere Elemente hinzufügen, aber erst nachdem wir diese Leitlinie verstanden haben.

A. DIE VERBINDUNG AUFKOMMENDER STRUKTUREN MIT DER BEWEGUNG

Das Verständnis dieser Bewegung ermöglicht es zu sehen, wie sich die **Ventrikel** bilden, wie die **Dura mater** folgt, wie sich der **Schädel** formt. Wenn etwas blockiert (eine Ebene, die ich noch nicht kenne), kann ich mich auf mein Wissen über das Timing und die synchronen Phänomene stützen.

Zum Beispiel kann ich nach einer **Arterie** oder einer spezifischen elektrischen Ebene suchen. Der Patient wird spüren können, was passiert.

B. DIE BEDEUTUNG DER HERZ-DYNAMIK

Es ist wichtig, die **Dynamik** des Herzens gut zu kennen. Manchmal ist die Expansion auf einer Seite stärker (zum Beispiel links).

C. VERMEIDUNG ÜBERMÄßIGER INTELLEKTUALISIERUNG

Es ist wichtig, das Gefühl nicht übermäßig zu intellektualisieren. Eine zu große mentale Aktivität kann "zu viel Elektrizität in das limbische System bringen" und die subtile Wahrnehmung beeinträchtigen.

V. PRAKTISCHER FALL: ANALYSE EINES GEFÜHLS

Bei einer Beurteilung:

- Die Expansion ist sanft, nicht vollständig. Die Flexion ist gut, aber es fehlt an Dynamisierung.
- Der Rhythmus ist variabel. Die Bewegung verlagert sich stärker auf eine linke Schiene, mit einer Verlangsamung.
- Es ist manchmal schwierig, den **Frontallappen** in der Tiefe zu erreichen.

A. FORTSCHREITEN DER BEWEGUNG

Danach geht es zum pontinen System über, mit einem Aufstieg des Patientenröhrchens. Ich werde zum Auflagepunkt, und es drückt. Der laterale Ausstoß, insbesondere rechts, beginnt stärker.

Der Patient "holt das Paket unten ab". Nach einem anfänglich etwas langsamen Start holt die Bewegung gut auf.

B. DIE AUSSAGE DES PATIENTEN

Der Patient beschreibt einen schwierigen Anfang, als ob man "in Gang kommen" müsste, eine Fixierung links loslassen, die die Expansion verhinderte. Die anfängliche Flexion war schwierig.

Als eine Verbindung hergestellt wurde, "entriegelte" sich das System. Das ist vergleichbar mit dem Erlernen des Fahrens eines **Formel-1-Wagens**: Am Anfang ist man ungeschickt, dann funktioniert es mit dem Lernen.

C. DIE SCHLÜSSEL ZUR BEGLEITUNG

- **Umgebung und Raum**: Atmen lassen, die Bewegung schwenken.
- **Progressivität**: Schrittweise eindringen und sich mit dieser "Schrift" des Körpers verbinden.
- **Zentrierung des Zuhörens**: Das Zuhören auf Gehirnebene zentrieren, und wenn es "nicht geht", woanders beobachten.

Es ist eine Frage der **Synchronizität**. Man muss "sich synchronisieren", um das richtige Wort zu finden und mit dieser Synchronizität zu arbeiten.

